

Flashcards ENARM -- Gineco-Obstetricia

50 patologías · 265 tarjetas · generado 2026-09-12 por La Mole. Frente = pregunta tipo ENARM; Reverso = respuesta + dato diferencial.

Aborto

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer con sangrado transvaginal antes de la semana 22 de gestación y cérvix cerrado a la exploración. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Amenaza de aborto (temprana <14 SDG, tardía 14-22 SDG); se distingue del aborto en evolución/inevitable porque este suma contracciones, hemorragia y modificaciones cervicales o ruptura de membranas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué concentración de β -hCG se correlaciona con la visualización del saco gestacional por ultrasonido transvaginal y qué obliga a descartar si el útero está vacío con ese nivel?

REVERSO: β -hCG >1500 mUI/mL para USG transvaginal (>6500 mUI/mL para USG abdominal); sin saco a ese nivel debe descartarse embarazo ectópico. Progesterona <5 ng/mL se asocia con muerte del producto.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Aborto diferido con útero menor que la amenorrea y sin vitalidad fetal. ¿Qué complicación puede presentarse 4-5 semanas después y qué parámetro se vigila?

REVERSO: Coagulación intravascular diseminada por liberación de fibrinógeno del producto en degradación; se vigila fibrinógeno hasta la expulsión o remoción. Se distingue del aborto incompleto por la ausencia de modificaciones cervicales.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Embarazo ≤ 9 semanas con aborto incompleto y paciente estable. ¿Manejo de primera línea y dosis?

REVERSO: Manejo médico con misoprostol 800 mcg por vía bucal en dosis única (alternativas: 600 mcg VO o 400 mcg sublingual; reducir a 200 mcg si es inevitable); a partir de ≥ 12 semanas, inductoconducción con misoprostol 400 mcg cada 3 h hasta expulsión.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer con pérdidas gestacionales repetidas. ¿Cómo define la GPC el aborto recurrente y cuándo se coloca cerclaje cervical?

REVERSO: Aborto habitual/recurrente: pérdida en dos o más ocasiones consecutivas o alternas (clásicamente ≥ 3); se investiga cariotipo de la pareja, antifosfolípidos y anomalías uterinas; cerclaje en primer trimestre con feto vivo en pacientes con ≥ 3 pérdidas o partos pretérmino previos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Aborto séptico. ¿Cómo se secuencia el manejo quirúrgico respecto al antibiótico, cuál es el esquema antibiótico y qué hallazgo sugiere Clostridium?

REVERSO: Antibióticos (ampicilina+gentamicina, clindamicina+metronidazol o la triple combinación) y cirugía 6-8 h después de iniciados; hemólisis con bacilos grampositivos de extremos turgentes y gas intramiometrial sugiere Clostridium perfringens. A toda Rh-negativa: inmunoglobulina anti-D.

Adenomiosis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Múltipara de 40 años con menorragia, dismenorrea y útero globular y sensible que se acentúa justo antes y durante la menstruación. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Adenomiosis (formas sintomáticas a los 35-50 años; asociada a paridad elevada y trauma uterino); se distingue de la miomatosis por el crecimiento globular y simétrico, no nodular.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué estudio de imagen tiene precisión diagnóstica superior para la adenomiosis?

REVERSO: Resonancia magnética, en particular la secuencia ponderada en T2 (moderadamente superior al USG transvaginal); el USG discrimina adenomiosis difusa frente a leiomiomas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el criterio histopatológico estándar del diagnóstico de adenomiosis?

REVERSO: Identificación de glándulas y estroma endometrial a una distancia >2.5 mm del recubrimiento basal endometrial; se diagnostica frecuentemente de forma incidental en la pieza de histerectomía (hasta 60% al final de la vida reproductiva).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Mujer con paridad satisfecha y adenomiosis sintomática. ¿Tratamiento definitivo y opciones conservadoras?

REVERSO: Histerectomía es el tratamiento definitivo; en paridad insatisfecha: progestinas, DIU liberador de progesterona, agonistas de GnRH e inhibidores de prostaglandinas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué complicaciones gestacionales aumentan en las pacientes con adenomiosis que logran embarazarse?

REVERSO: Trabajo de parto prematuro, peso bajo al nacer y ruptura prematura de membranas.

Amenorrea y Oligomenorrea

Tarjeta 1 -- FRENTE: Adolescente sin menarca. ¿Cómo se define la amenorrea primaria y cuándo debe iniciarse su estudio?

REVERSO: Ausencia de menarca a los 15 años; el estudio se inicia antes de los 16, a los 14 si no hay telarca, o si la menarca no ocurre en los 2 años posteriores a la telarca. Oligomenorrea: ciclos con intervalos >35-45 días.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Amenorrea primaria con infantilismo sexual. ¿Cuál es el primer paso para separar el hipogonadismo hipogonadotrópico del hipergonadotrópico?

REVERSO: FSH basal: baja en el hipogonadotrópico (exige RM/tomografía hipotálamo-hipofisaria por craneofaringioma) y elevada en el hipergonadotrópico (disgenesia gonadal; cariotipo para descartar cromosoma Y, p. ej. Turner 45,X0).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Hipogonadismo hipogonadotrópico asociado a anosmia o hiposmia. ¿Síndrome?

REVERSO: Síndrome de Kallmann; distinguir del retraso puberal constitucional sólo tras excluir causas serias.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Adolescente con amenorrea primaria, desarrollo mamario, testículos internos, ausencia de útero y testosterona sérica masculina, cariotipo 46,XY. ¿Diagnóstico y cómo se distingue de la agenesia mülleriana?

REVERSO: Síndrome de insensibilidad completa a andrógenos; la testosterona elevada y el cariotipo 46,XY lo separan de la agenesia mülleriana (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, 46,XX). Ante anomalías müllerianas está indicada pielografía intravenosa por anomalías renales asociadas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer con amenorrea y galactorrea. ¿Fármaco de elección y ejemplos de causas farmacológicas de hiperprolactinemia?

REVERSO: Cabergolina (bromocriptina como alternativa); causas farmacológicas: metoclopramida, fenotiazinas, risperidona, antidepresivos tricíclicos, metildopa, verapamilo. Cirugía si hay síntomas visuales o expansión supraselar.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es la evaluación inicial de la amenorrea con desarrollo mamario y estructuras müllerianas normales?

REVERSO: Prueba de embarazo, FSH y reto con progestina (o estradiol sérico); causas frecuentes: embarazo, síndrome de Asherman (cicatrices en histerosalpingografía), hiperprolactinemia y falla ovárica precoz (FSH elevada).

Anticoncepción y Planificación Familiar

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el método anticonceptivo reversible más eficaz y cuál es su única contraindicación absoluta?

REVERSO: Implante subdérmico (tasa de embarazo 0.05%); única contraindicación absoluta: cáncer mamario activo en los últimos 5 años. Es método efectivo en pacientes con peso >70 kg.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Mujer con coito sin protección hace 96 horas. ¿Método anticonceptivo de emergencia de elección?

REVERSO: DIU de cobre dentro de las 120 horas postcoito: método de emergencia más efectivo y de inicio rápido; si no es aceptable, anticoncepción hormonal (levonorgestrel 1.5 mg VO dosis única).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la dosis y ventana del levonorgestrel para anticoncepción de emergencia?

REVERSO: Levonorgestrel 1.5 mg VO en dosis única (o 0.75 mg en 2 dosis separadas 12 h) dentro de las primeras 120 horas, con máxima eficacia <72 h; no es teratígeno y no cubre el resto del ciclo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué condiciones clasifican como categoría 4 (contraindicación absoluta) de los anticonceptivos combinados en los CEM de la OMS?

REVERSO: Migraña con aura, trombosis venosa profunda actual o pasada, apoplejía cerebral y cáncer mamario actual; para el DIU de cobre esas mismas condiciones son categoría 1.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuáles son las contraindicaciones NOM de los anticonceptivos orales combinados?

REVERSO: Lactancia en los primeros 6 meses posparto, embarazo, enfermedad tromboembólica actual o pasada, cáncer mamario o cervicouterino, tumores hepáticos, hepatopatía activa y administración crónica de rifampicina o anticonvulsivantes.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuáles son los intervalos de los anticonceptivos inyectables y cómo se logra la esterilización definitiva en la mujer?

REVERSO: Medroxiprogesterona IM cada 12 semanas y noretisterona IM cada 8 semanas; OTB (salpingoclasia) por técnica de Pomeroy, la más usada, con tasa de falla de 1 en 200 similar al DIU.

Cáncer Cervicouterino

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué virus y genotipos causan la mayoría de los cánceres cervicouterinos y cuál es su mecanismo molecular?

REVERSO: VPH de alto riesgo: los tipos 16 y 18 causan 70%; las proteínas E6 y E7 inhiben p53 y Rb, desregulando el ciclo celular.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Mujer de 47 años con sangrado poscoital como único síntoma y cérvix friable. ¿Sospecha y confirmación?

REVERSO: Cáncer cervicouterino temprano (el sangrado poscoital, intermenstrual o posmenstrual es el único síntoma temprano); confirmar con colposcopia y biopsia dirigida.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la estrategia de tamizaje del cáncer cervicouterino y a qué edades se aplica?

REVERSO: Detección de DNA-VPH de alto riesgo más citología cervical cada 5 años, de los 25 a los 65 años; continuar después de los 65 si hay inmunosupresión, VIH o prueba molecular positiva.

Tarjeta 4 -- FRENTE: NIC III en citología. ¿Cuál es su riesgo evolutivo y conducta?

REVERSO: 35% evoluciona a cáncer invasor en 10 años; tratamiento activo (escisión con asa, criocirugía o conización si la zona de transición no es visible); NIC I: conducta expectante. Durante el embarazo sólo expectante.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Carcinoma cervicouterino estadio IB2-IVA. ¿Tratamiento de elección?

REVERSO: Quimiorradioterapia concomitante con cisplatino y radioterapia externa (consolidación con braquiterapia si riesgo de recurrencia); estadios IA1-IB1: cirugía (histerectomía radical y linfadenectomía o traquelectomía preservadora de fertilidad).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué hallazgo define el estadio IIIB FIGO y qué conducta implica?

REVERSO: Hidronefrosis o disfunción renal por extensión tumoral (clasificable con USG abdominal y urografía excretora); quimio-radiación; supervivencia a 5 años del estadio III: 20-30%.

Cáncer Endometrial

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 58 años posmenopáusica con sangrado transvaginal. ¿Diagnóstico a descartar primero y prueba definitiva?

REVERSO: Cáncer endometrial; la biopsia endometrial es la prueba diagnóstica definitiva (especificidad de 90%).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué factor hormonal unifica los factores de riesgo del cáncer endometrial?

REVERSO: Estimulación estrogénica prolongada sin oposición por progestágenos: obesidad, nuliparidad, menopausia tardía, diabetes, hipertensión, tamoxifeno y síndrome de Lynch; el tabaquismo podría ser protector.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente del cáncer endometrial?

REVERSO: Adenocarcinoma endometriode (75%); las variantes de células claras, seroso y escamoso son menos frecuentes y de pronóstico más precario.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Sangrado transvaginal profuso e irregular: ¿en qué pacientes está indicado el ultrasonido?

REVERSO: Si concurren peso >90 kg, edad >45 años o antecedente de hiperplasia atípica/cáncer endometrial; el sangrado posmenopáusico se refiere a ginecología de segundo nivel.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico del cáncer endometrial estadio I?

REVERSO: Lavado peritoneal, histerectomía extrafascial, salpingooforectomía bilateral y linfadenectomía pélvica y paraaórtica bilateral, con radioterapia y/o quimioterapia adyuvantes según el riesgo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué marcador tumoral se solicita ante sospecha de extensión extrauterina del cáncer endometrial?

REVERSO: CA-125, útil también para monitorizar la respuesta clínica.

Cáncer Mamario

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué mutaciones hereditarias confieren el mayor riesgo de cáncer mamario y en qué loci se encuentran?

REVERSO: BRCA1 (17q21) confiere 70% de riesgo de cáncer mamario a los 65 años y BRCA2 (13q12.3) 40%; ambas aumentan el riesgo de cáncer ovárico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Mastografía con nódulo de bordes espiculados y microcalcificaciones finas agrupadas. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Carcinoma mamario; los signos mastográficos de malignidad son microcalcificaciones, bordes espiculados, retracción de tejido, alteraciones vasculares y halo radiolúcido perilesional.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el método más eficaz de cribado del cáncer de mama y su intervalo en mujeres de 40-49 años?

REVERSO: Mastografía; en asintomáticas de 40-49 años con riesgo promedio, anual (50-74 años: cada 1-2 años). El ultrasonido complementa en tejido denso y menores de 30 años.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué categoría BI-RADS obliga a biopsia inmediata?

REVERSO: BI-RADS 5 (probabilidad de malignidad >95%): referencia <10 días y biopsia; BI-RADS 4 (3-94%) considera biopsia; BI-RADS 3 (<2%) sólo seguimiento semestral.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer con carcinoma ductal infiltrante de 2 cm y 3 ganglios axilares positivos, receptores hormonales negativos. ¿Tratamiento adyuvante?

REVERSO: Quimioterapia adyuvante: la positividad ganglionar la indica sin importar el estado de receptores hormonales; esquemas con antraciclinas y taxanos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué terapia endocrina se indica en la premenopáusica con receptores hormonales positivos y cuáles son sus toxicidades?

REVERSO: Tamoxifeno por 5 años (en posmenopáusicas, inhibidores de la aromatasas); toxicidades: eventos tromboembólicos y cáncer endometrial. Con HER2+: trastuzumab (cardiomiopatía dilatada; no combinable con antraciclinas).

Cáncer Vulvar

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es la histología más frecuente del cáncer vulvar y qué proporción representa?

REVERSO: Carcinoma epidermoide (~90%); siguen melanomas (5-10%), adenocarcinomas de las glándulas de Bartholin, sarcomas y carcinoma de células basales.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué dos vías carcinogénicas se reconocen en el cáncer de vulva?

REVERSO: Dependiente del VPH (60% de los casos, subtipos 16 y 33, precedida por neoplasia intraepitelial vulvar usual) e independiente del VPH (carcinoma queratinizante por inflamación crónica, p. ej. liquen escleroso).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Mujer de 70 años con lesión vulvar ulcerada, dolorosa y sangrante. ¿Cómo se establece el diagnóstico definitivo?

REVERSO: Biopsia de la lesión; ante sospecha se apoya con colposcopia con ácido acético y tomografía de pelvis e ingles.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Lesión vulvar temprana de 1.5 cm sin comprometer la línea media frente a una de 3 cm que sí la compromete: ¿tratamiento de cada una?

REVERSO: Temprana ≤2 cm sin línea media: resección local amplia; >2 cm o que compromete la línea media: vulvectomy radical modificada.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el principal factor pronóstico del cáncer vulvar?

REVERSO: La afectación ganglionar regional (inguinal y femoral); supervivencia global a 5 años de 72.1%, 86% si está localizado.

Cervicovaginitis - Generalidades

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué tres agentes explican hasta 90% de las vaginitis?

REVERSO: Vaginosis bacteriana (40-50%), candidiasis vulvovaginal (20-25%) y tricomoniasis (<15%); el pH vaginal normal es 3.5-4.5.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Leucorrea maloliente blanca-grisácea homogénea, pH >4.5, prueba de KOH al 10% positiva con olor aminado y células clave. ¿Diagnóstico, criterios y tratamiento de elección?

REVERSO: Vaginosis bacteriana: criterios de Amsel positivos con ≥ 3 de 4; metronidazol 400-500 mg VO cada 12 h por 5-7 días (alternativa: 2 g VO dosis única).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Prurito vulvar intenso con leucorrea grumosa blanca no fétida y pH <4.5. ¿Diagnóstico y tratamiento en la no gestante y en la gestante?

REVERSO: Candidiasis vulvovaginal (KOH negativo, levaduras y pseudomicelios al microscopio); no gestante: fluconazol 150 mg VO dosis única o nistatina 100,000 UI por 14 días; gestante: clotrimazol crema por 14 días.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué grado de los criterios de Hay-Ison define la vaginosis bacteriana en el Gram?

REVERSO: Grado III: predominio de Gardnerella o Mobiluncus con lactobacilos escasos o ausentes (grado I normal: predominio de Lactobacillus).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuáles son los factores de riesgo de la candidiasis vulvovaginal?

REVERSO: Anticonceptivos orales a dosis altas, diabetes mellitus, antibióticos, embarazo, inmunosupresión y diafragma con espermicida; la recurrencia se define con ≥ 4 episodios al año.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Mujer climatérica con irritación vaginal. ¿Causa más común y tratamiento?

REVERSO: Vaginitis atrófica (tejidos hipoestrogenizados); tratamiento de elección: estrógenos tópicos (cremas, supositorios o anillos vaginales).

Clamidiasis (Chlamydia trachomatis)

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente?

REVERSO: Clamidiasis (Chlamydia trachomatis).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Úlcera genital indolora acompañada de adenopatías dolorosas. ¿Entidad, serotipos y prueba diagnóstica?

REVERSO: Linfogranuloma venéreo por serotipos L1-L3 de C. trachomatis; serología positiva para L1-L3 y NAAT como prueba general de diagnóstico.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la prueba de elección para el diagnóstico de la clamidiasis?

REVERSO: NAAT (prueba de amplificación de ácidos nucleicos).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento del linfogranuloma venéreo y qué coinfección debe descartarse?

REVERSO: Doxiciclina o eritromicina durante 21 días; descartar coinfección por Neisseria gonorrhoeae, frecuente.

Condiciones Mamarias Benignas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 25 años con masa mamaria móvil, circunscrita, indolora y solitaria. ¿Tumor benigno más común y tratamiento?

REVERSO: Fibroadenoma (tejido fibroso y glandular, antes de los 30 años, crece con el embarazo); exéresis quirúrgica cuando mide 2-4 cm.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el trastorno mamario benigno más común y cómo se presenta?

REVERSO: Hiperplasia (50%): lesiones múltiples, bilaterales, dolorosas y sensibles, peores en el periodo premenstrual, que mejoran con embarazo y lactancia; con atipia celular aumenta el riesgo de malignidad.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Descarga hemática espontánea por el pezón sin masa palpable. ¿Lesión probable y tratamiento de elección?

REVERSO: Papiloma intraductal; biopsia escisional de la lesión y del ducto (cirugía de Addair).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Puérpera lactante con mama unilateral eritematosa, hipertérmica e indurada. ¿Tratamiento de la mastitis puerperal y conducta si hay absceso?

REVERSO: Drenaje de la leche más antibiótico resistente a β -lactamasas con actividad sobre *S. aureus* (amoxicilina-clavulanato, dicloxacilina, cefalexina); ante absceso: incisión y drenaje con toma de muestra para cultivo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué significa el carcinoma lobulillar in situ para la paciente?

REVERSO: Marcador de riesgo, no un cáncer: RR de 5.4 para cáncer mamario bilateral; células en anillo de sello, multicéntrico y frecuentemente bilateral; tratamiento: biopsia escisional con o sin tamoxifeno.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Mujer en lactancia con masa quística blanda cuya aspiración con aguja obtiene contenido lechoso. ¿Diagnóstico y conducta?

REVERSO: Galactocele (ducto lácteo obstruido); no requiere escisión y no incrementa el riesgo de cáncer mamario posterior.

Depresión Perinatal (Prenatal y Posparto)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer al día 3 posparto con labilidad emotiva y llanto fácil que se resuelve en dos semanas. ¿Diagnóstico y diferencial con la depresión posparto?

REVERSO: Melancolía puerperal (baby blues): aparece entre los días 2-4, se alivia espontáneamente en 2-3 semanas y no requiere tratamiento; la depresión posparto dura >2 semanas con deterioro funcional.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la herramienta de tamizaje preferida en el periodo perinatal y su punto de corte?

REVERSO: Escala de Edimburgo (EDPE): 10 ítems, máximo 30 puntos; puntuación >10 = sospecha de depresión mayor; cualquier puntaje distinto de cero en el ítem 10 (ideación suicida) obliga a evaluar riesgo de suicidio.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la depresión perinatal?

REVERSO: No farmacológico: terapia cognitivo conductual (TCC), consejería y actividad física estructurada; si no hay mejoría a los 4-6 meses, referir a tercer nivel.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Puérpera lactante con depresión mayor que requiere fármaco. ¿Qué antidepresivos son de primera línea?

REVERSO: Sertralina o paroxetina: ISRS con menor excreción en la leche materna; los ISRS son el grupo de primera elección.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué ISRS está contraindicado en el primer trimestre del embarazo y por qué?

REVERSO: Paroxetina, por asociación con mayor riesgo de defectos cardíacos fetales; en general debe evitarse antidepresivos durante las primeras 12 semanas de gestación.

Disfunción Genitourinaria

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el sitio más frecuente de prolapso vaginal y cómo se estadifica el prolapso de órganos pélvicos?

REVERSO: La pared vaginal anterior (cistocele); el sistema POP-Q mide 6 puntos en centímetros respecto a las carúnculas mirtiformes (línea del himen).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Incontinencia urinaria con la tos y el esfuerzo. ¿Terapia inicial de elección y único fármaco aprobado?

REVERSO: Ejercicios de Kegel (rehabilitación del piso pélvico); duloxetine es el único fármaco aprobado para la incontinencia de esfuerzo; cirugía: malla suburetral libre de tensión.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Incontinencia de urgencia con frecuencia y nicturia (hiperactividad vesical). ¿Tratamiento inicial y farmacológico?

REVERSO: Entrenamiento vesical por al menos 6 semanas (meta: micciones cada 3-4 h) más antimuscarínicos: oxibutinina, tolterodina, trospio o propiverina.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué maniobra confirma la presencia y grado del prolapso en la exploración física?

REVERSO: Exploración pélvica bimanual con espéculo vaginal y maniobra de Valsalva para visualizar el descenso.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer anciana con prolapso masivo que no tolera cirugía mayor y no desea conservar función coital. ¿Opción quirúrgica?

REVERSO: Colpocleisis (obliteración vaginal), reservada para ancianas sin capacidad para manejo más invasivo; el pesario es la alternativa conservadora en cualquier estadio.

Dismenorrea

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo define la GPC la dismenorrea?

REVERSO: Dolor cólico en el abdomen bajo durante la menstruación, por más de 3 ciclos menstruales, con duración de 4-96 horas; es la forma más común de dolor pélvico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Adolescente con dolor cólico que inicia horas antes de la menstruación y dura 48-72 h, sin hallazgos en la exploración. ¿Fisiopatología y tratamiento de primera línea?

REVERSO: Dismenorrea primaria: exceso de prostaglandinas F2 α y E2 con contracciones e isquemia uterina en ciclos ovulatorios; AINE (ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico) y anticonceptivos hormonales.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Mujer de cuarta-quinta década con dolor pélvico que persiste antes y después de la menstruación, con dispareunia e infertilidad. ¿Sospecha?

REVERSO: Dismenorrea secundaria por enfermedad pélvica orgánica (endometriosis, EPI, adenomiosis, miomatosis); el tratamiento es la resolución del trastorno subyacente.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué características del dolor sugieren endometriosis como causa de dismenorrea secundaria?

REVERSO: Dolor que se extiende a la fase premenstrual o posmenstrual o es continuo, con dispareunia profunda, sangrado escaso premenstrual y nódulos pélvicos sensibles en los ligamentos uterosacros.

Distocias y Parto Vaginal Instrumentado

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se define la fase latente prolongada del trabajo de parto?

REVERSO: Nulípara: >20 horas; multípara: >14 horas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Trastorno activo de la dilatación: ¿qué velocidades de dilatación definen el patrón anormal con contracciones adecuadas?

REVERSO: Primípara: <1.2 cm/hora; multípara: <1.5 cm/hora.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuándo se considera segundo estadio prolongado?

REVERSO: Nulípara: >2 h sin anestesia regional (>3 h con anestesia regional); multípara: >1 h (>2 h con anestesia regional).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tras el nacimiento de la cabeza, los hombros no nacen en más de 60 segundos. ¿Diagnóstico y primera maniobra?

REVERSO: Distocia de hombros; iniciar con maniobra de McRoberts con presión suprapúbica, seguida de Woods (sacacorchos), extracción del brazo posterior, fractura de clavículas y, al final, Zavanelli con cesárea.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Situación transversa con feto viable en trabajo de parto. ¿Vía de nacimiento?

REVERSO: Operación cesárea (indicación absoluta); la versión interna sólo está indicada para la extracción del segundo gemelo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué lesiones fetales se asocian al fórceps y cuáles al vacuum?

REVERSO: Fórceps: lesión del nervio facial, del plexo braquial, fractura deprimida de cráneo y abrasión corneal; vacuum: cefalohematoma, hemorragia subgaleal y retiniana, e ictericia neonatal.

Embarazo Ectópico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer en edad reproductiva con amenorrea, dolor pélvico y sangrado transvaginal. ¿Principal causa de muerte materna del primer trimestre y localización más frecuente?

REVERSO: Embarazo ectópico: >95% tubárico, 70% en la porción ampular; la triada clásica (dolor, sangrado, masa anexial) sólo se encuentra en 45% de los casos.

Tarjeta 2 -- FRENTE: β -hCG >1500 UI/L con útero vacío en ultrasonido transvaginal. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Embarazo ectópico (imagen en anillo de fuego con Doppler); un embarazo intrauterino no descarta el heterotópico, especialmente tras fertilización in vitro.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente estable, β -hCG 2000 UI/L, saco de 30 mm sin latido cardíaco, sin dolor ni sangrado activo. ¿Manejo médico y con qué fármaco?

REVERSO: Metotrexato (con o sin ácido folínico): criterios GPC con β -hCG <3000 UI/L, saco <35-40 mm y sin actividad cardíaca; exige anticoncepción efectiva por al menos 3 meses después.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas del metotrexato en el embarazo ectópico?

REVERSO: Lactancia, disfunción renal, hepática, pulmonar o hematológica, hipersensibilidad al fármaco y enfermedad ácido-péptica; relativas: saco >40 mm o actividad cardíaca embrionaria.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Ruptura tubárica con inestabilidad hemodinámica. ¿Manejo de elección?

REVERSO: Cirugía urgente (laparoscopia o laparotomía) con salpingectomía; indicaciones de salpingectomía: daño tubario, ectópico recurrente, sangrado persistente, saco >5 cm, paridad satisfecha e inestabilidad hemodinámica.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué criterios completos permiten el manejo expectante del embarazo ectópico?

REVERSO: Estabilidad hemodinámica + β -hCG <1000 UI/L en descenso + sin líquido libre o <100 cc en fondo de saco + masa anexial <2 cm + ausencia de embriocardio.

Embarazo Múltiple

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué proporción de los embarazos gemelares es dicigótica y qué factores se asocian?

REVERSO: 75-80% dicigóticos; asociados a reproducción asistida, inductores de la ovulación, edad materna avanzada, predisposición familiar y obesidad materna.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Cronología de la división de gemelos monocigóticos: ¿qué resultan la división a los 4-8 días y la división después de los 12 días?

REVERSO: 4-8 días: biamnióticos monocoriónicos; después de 12 días: gemelos unidos (siameses); primeros 3 días: biamniótico bicoriónico; 8-12 días: monoamniótico monocoriónico.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿En qué semanas se determina la corionicidad y qué signos ultrasonográficos la definen?

REVERSO: Entre 11 y 13.6 semanas; signo Lambda (tejido placentario entre las membranas) = bicorial; signo de la T = monocorial; sexo fetal discordante asegura gestación bicorial.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Gemelos monocoriales con bolsillo mayor vertical ≤ 2 cm en un saco y ≥ 8 cm en el otro. ¿Diagnóstico y tratamiento de elección?

REVERSO: Síndrome de transfusión feto-fetal (10-15% de los gemelares monocoriales): fetoscopia con coagulación láser de las anastomosis vasculares.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Gemelaridad cefálico-cefálica en trabajo de parto. ¿Vía preferida y conducta si el segundo gemelo no nace?

REVERSO: Parto vaginal preferido (73% de éxito); cesárea si transcurren ≥ 30 minutos entre el nacimiento del primer y el segundo gemelo. El parto pretérmino ocurre en 50% de los embarazos múltiples.

Emergencias Obstétricas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Parturienta con hipotensión súbita (PAS < 90 mmHg), cianosis y coagulación intravascular diseminada durante el parto. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Embolismo de líquido amniótico: cuadro durante el parto, nacimiento o hasta 30 min posalumbramiento, con CID y sin fiebre; diagnóstico clínico por exclusión y tratamiento sólo de soporte.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Primigesta de tercer trimestre con náusea, prurito, dolor en hipocondrio derecho, bilirrubinas y transaminasas elevadas, plaquetas bajas y coagulación prolongada. ¿Diagnóstico y tratamiento?

REVERSO: Hígado graso agudo del embarazo; hospitalización y terminación del embarazo manteniendo INR < 1.5 y plaquetas $> 50,000/\text{mm}^3$; casos graves: plasmaféresis o trasplante hepático.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Embarazada con sospecha de trombosis venosa profunda. ¿Estudio de elección y por qué no se solicita dímero D?

REVERSO: Ultrasonido por compresión; el dímero D no debe solicitarse en la obstétrica por elevarse fisiológicamente con la gestación; tratamiento: HBPM (enoxaparina), no antagonistas de vitamina K por teratogenicidad.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Anti-tiroideo de elección por trimestre durante el embarazo.

REVERSO: Propiltiouracilo en el primer trimestre (menor teratogenicidad), cambiando a metimazol a partir del segundo por riesgo de toxicidad hepática grave materna; el yodo radiactivo está contraindicado en la gestación.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Gestante con náuseas y vómitos incoercibles, pérdida de peso $> 5\%$ del pregestacional y alteraciones electrolíticas. ¿Tratamiento de primera línea?

REVERSO: Hiperemesis gravídica; antihistamínicos H1 de primera elección (metoclopramida y ondansetrón de segunda), terapia hídrica parenteral y tiamina en casos graves.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Desaceleraciones variables súbitas y cordón palpado en el canal vaginal. ¿Diagnóstico y manejo?

REVERSO: Prolapso del cordón umbilical: posición fetal (decúbito lateral con rodillas y cara al pecho), elevación de la presentación (manual o llenado vesical con 500 ml) y cesárea de urgencia si el nacimiento vaginal no es inminente.

Endometriosis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 32 años nulípara con dolor pélvico cíclico que inicia 1-2 días antes de la menstruación, dispareunia profunda y sangrado escaso premenstrual. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Endometriosis (tejido endometrial funcional fuera de la cavidad uterina); subtipos: superficial o peritoneal, ovárica o endometrioma, y profunda o extrapélvica.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el método diagnóstico definitivo de la endometriosis y el primer estudio de imagen?

REVERSO: Histopatología de las lesiones obtenidas por laparoscopia o laparotomía (estándar definitivo); el USG transvaginal es el primer método de imagen y la RM es de segunda elección.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué marcador sérico se solicita en la evaluación de la endometriosis y cuál es su limitación?

REVERSO: CA-125, con valor predictivo positivo de 20% (poco específico); se apoyan también CA-19.9 y HE-4.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento médico de primera línea de la endometriosis sospechada.

REVERSO: AINE y anticonceptivos orales a dosis bajas o acetato de medroxiprogesterona durante al menos 3-6 meses; segunda línea: agonistas de GnRH (goserelina) combinados con terapia hormonal para prevenir osteoporosis.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Endometrioma ovárico de 5 cm en paciente con deseo de fertilidad. ¿Manejo quirúrgico?

REVERSO: Laparoscopia preservadora de fertilidad removiendo todos los endometriomas >4 cm, prefiriendo la escisión sobre el drenaje y coagulación; tratamiento definitivo: histerectomía total abdominal con salpingo-ooforectomía bilateral.

Enfermedad Pélvica Inflamatoria

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes de la enfermedad pélvica inflamatoria?

REVERSO: Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, en una infección habitualmente polimicrobiana; se presenta sobre todo en mujeres de 15-29 años.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Dolor a la movilización cervical en la exploración pélvica. ¿Cómo se llama el signo y qué conducta implica?

REVERSO: Signo de Chandelier (del candelabro); ante tumefacción e hipersensibilidad anexiales y cervical, debe administrarse tratamiento antibiótico a toda mujer sexualmente activa con umbral diagnóstico bajo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de la EPI?

REVERSO: Laparoscopia con hallazgo de tumefacción y eritema de las salpinges; también diferencia embarazo ectópico, tumoraciones anexiales y apendicitis.

Tarjeta 4 -- FRENTE: EPI leve-moderada en manejo ambulatorio. ¿Esquema antibiótico de elección?

REVERSO: Ceftriaxona dosis única más doxiciclina, con o sin metronidazol, por 14 días (hospitalizadas: ceftriaxona/cefotetán/cefoxitina IV + doxiciclina ± metronidazol, 14 días).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuáles son las indicaciones de hospitalización en la EPI?

REVERSO: Absceso tubo-ovárico (aunque no esté roto), embarazo, enfermedad grave o fiebre, falla del tratamiento ambulatorio tras 72 h, intolerancia a antibióticos orales y no poder excluir urgencia quirúrgica.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué complicaciones crónicas produce la EPI y cuándo se drena el absceso tubo-ovárico?

REVERSO: Dolor pélvico crónico (30%), infertilidad (20%), embarazo ectópico (10%) y síndrome de Fitz-Hugh-Curtis; drenaje quirúrgico ante fracaso antibiótico, diámetro de 10 cm o ruptura del absceso.

Enfermedad Trofoblástica Gestacional

Tarjeta 1 -- FRENTE: Sangrado vaginal indoloro en el primer trimestre con útero mayor que la amenorrea, hCG muy elevada y ausencia de latido fetal. ¿Diagnóstico y hallazgo ultrasonográfico?

REVERSO: Mola hidatidiforme completa; USG con patrón difuso ecogénico mixto en tormenta o copos de nieve (panal de abejas).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué cariotipos distinguen la mola hidatidiforme completa de la parcial?

REVERSO: Completa: 46,XX con cromosomas de origen paterno; parcial: triploide 69,XXY (80%), es la forma más frecuente en México y suele coexistir con feto triploide defectuoso.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Mola en primer trimestre con datos de preeclampsia y quistes teca-luteínicos. ¿Por qué ocurren?

REVERSO: Por la producción excesiva de hCG: preeclampsia, hiperemesis y síntomas de hipertiroidismo; un tercio presenta agrandamiento ovárico por quistes teca-luteínicos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de elección de la enfermedad trofoblástica gestacional y qué procedimiento está proscrito?

REVERSO: Histerectomía con preservación ovárica en casos seleccionados (disminuye 97% el riesgo de evolución maligna); con paridad insatisfecha, aspirado endometrial; proscrita la inducción del trabajo de aborto en todo el espectro.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué criterios de β -hCG después de la evacuación molar indican malignidad?

REVERSO: Meseta con fluctuaciones $\pm 10\%$ en cuatro mediciones (días 1, 7, 14 y 21), incremento $>10\%$ en tres mediciones (días 1, 7 y 14) o persistencia detectable a los 6 meses; cualquiera indica quimioterapia.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cómo se realiza el seguimiento tras la evacuación o histerectomía por mola?

REVERSO: β -hCG seriada semanal hasta negativización y mensual hasta 6 meses, con exploración física y radiografía torácica; anticoncepción confiable y no embarazo hasta 6-12 meses después de la remisión completa.

Enfermedades de la Vulva - Generalidades

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer con prurito vulvar agudo. ¿Qué causas infecciosas y factores de riesgo deben considerarse?

REVERSO: Tricomoniasis, candidiasis, molusco contagioso e infestaciones; factores de riesgo: diabetes mellitus, obesidad y uso de antibióticos de espectro amplio.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Prurito vulvar crónico. ¿Qué grupos de causas deben explorarse?

REVERSO: Dermatitis (liquen escleroso, liquen plano, psoriasis, dermatitis), neoplasias (neoplasia intraepitelial vulvar, enfermedad de Paget, cáncer vulvar), infección por VPH y manifestaciones vulvares de enfermedades sistémicas (enfermedad de Crohn).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué dermatosis vulvar es factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de vulva?

REVERSO: Liquen escleroso, con niveles elevados de autoanticuerpos y relación con antecedentes de autoinmunidad.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la colposcopia o la biopsia vulvar?

REVERSO: Ante sospecha de infección por VPH o de malignidad (neoplasia intraepitelial vulvar, enfermedad de Paget, cáncer de vulva); las verrugas en pacientes pediátricas no la requieren.

Fístula Vesico-vaginal

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se clasifican las fístulas vesico-vaginales?

REVERSO: Congénitas y adquiridas; las adquiridas se subdividen en iatrógenas y no iatrógenas (comunicación anómala entre las superficies epiteliales de vejiga y vagina).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué antecedente prototípico predispone a la fístula vesico-vaginal?

REVERSO: Histerectomía y cirugía ginecológica previa; también radiación, carcinomas pélvicos avanzados, parto traumático, cuerpos extraños (sondas) e infecciones como tuberculosis.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Mujer poshisterectomía con pérdida continua e involuntaria de orina por la vagina, sin relación con el esfuerzo. ¿Sospecha?

REVERSO: Fístula vesico-vaginal: la pérdida es continua, independiente del esfuerzo o la posición, lo que la distingue de la incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Con qué entidades debe diferenciarse la fístula vesico-vaginal?

REVERSO: Con la incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia, y con la fístula rectovaginal en el contexto de enfermedad pélvica avanzada.

Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Hombre joven con descarga uretral purulenta y disuria tres días después de una relación sexual de riesgo. ¿Agente y periodo de incubación?

REVERSO: Gonorrea por *Neisseria gonorrhoeae* (diplococo gramnegativo intracelular); incubación de 2-5 días.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cómo se presenta la gonorrea en la mujer?

REVERSO: Hasta 50% es asintomática; el resto cursa con flujo vaginal, dolor abdominal y metrorragia.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué complicaciones produce la gonorrea en la mujer?

REVERSO: Enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis y abscesos tubo-ováricos, causas de infertilidad y embarazo ectópico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de la gonorrea y por qué se asocia azitromicina?

REVERSO: Ceftriaxona más azitromicina; la azitromicina cubre la coinfección frecuente con *Chlamydia trachomatis*. Diagnóstico: NAAT como estándar actual, tinción de Gram (alta sensibilidad en hombres) y cultivo en Thayer-Martin.

Gonorrea

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el periodo de incubación de la gonorrea y en qué población el riesgo es mayor?

REVERSO: 2-5 días; alto riesgo en adolescentes y adultos jóvenes.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Mujer con flujo vaginal, dolor abdominal y metrorragia; la mitad de las pacientes cursa sin síntomas. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Gonorrea (*Neisseria gonorrhoeae*): hasta 50% de las mujeres es asintomática.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es la prueba diagnóstica actual de elección para la gonorrea y cuál tiene alta sensibilidad en hombres?

REVERSO: NAAT (pruebas de amplificación de ácidos nucleicos); la tinción de Gram tiene alta sensibilidad en hombres por la descarga uretral; el cultivo se realiza en Thayer-Martin.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué esquema antibiótico recibe la paciente con gonorrea y con qué diagnóstico diferencial se debe plantear?

REVERSO: Ceftriaxona más azitromicina para cubrir la coinfección frecuente con *Chlamydia trachomatis*; diferencial con clamidiasis y tricomoniasis.

Hemorragia Obstétrica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 32 años, 30 semanas de gestación, con sangrado vaginal indoloro de inicio súbito; útero no doloroso. ¿Diagnóstico más probable y qué maniobra está prohibida?

REVERSO: Placenta previa (70% cursa con sangrado indoloro en el tercer trimestre). Dato diferencial: el desprendimiento placentario sangra de forma dolorosa con útero hipertónico; ante sospecha de previa está prohibido el tacto vaginal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de placenta previa?

REVERSO: Ultrasonido transvaginal (sensibilidad cercana a 100%); el abdominal solo alcanza 95%. Dato diferencial: la inserción baja (borde a <20 mm del OCI sin cubrirlo) sí permite valorar parto vaginal con vigilancia estrecha.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Gestante de 34 semanas con sangrado vaginal doloroso, útero hipersensible y en tabla, FCF anormal y fibrinógeno en descenso. ¿Diagnóstico y complicación característica?

REVERSO: Desprendimiento placentario (sangrado doloroso con sensibilidad e hiperactividad uterinas). Es la causa más común de coagulación intravascular diseminada en el embarazo; con muerte fetal se indica parto vaginal y los tocolítics están contraindicados.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Multipara con cesárea previa en trabajo de parto presenta dolor suprapúbico intenso súbito, sangrado y patrón cardíaco fetal anormal. ¿Diagnóstico y tratamiento?

REVERSO: Ruptura uterina: el patrón cardíaco fetal anormal es el hallazgo más consistente (66-76%); requiere cesárea de emergencia y la histerectomía es el tratamiento de elección. Dato diferencial: con cicatriz uterina no deben usarse prostaglandinas E1/E2 para inducir.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cómo se define la hemorragia posparto (HPP) y cuál es su causa más frecuente?

REVERSO: Pérdida ≥ 1000 ml dentro de las 24 horas posteriores al parto o cualquier pérdida con signos de hipovolemia. La atonía uterina ('tono' de las 4 T) causa ~70% de las HPP: útero flácido con sangrado rojo rutilante.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Manejo farmacológico de primera línea de la HPP y hemostático antifibrinolítico.

REVERSO: Oxitocina IV o IM (10 UI); si persiste, agregar ergonovina IM (contraindicada en trastornos hipertensivos) o misoprostol; ácido tranexámico 1 g IV dentro de las primeras 3 horas. Dato diferencial: con preeclampsia-eclampsia no usar almidones ni dextrán.

Hemorragia Uterina Anormal

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué mnemotécnica de la FIGO clasifica la hemorragia uterina anormal y qué distingue a cada grupo?

REVERSO: PALM-COEIN: PALM = causas estructurales (pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad/hiperplasia); COEIN = no estructurales (coagulopatía, disfunción ovárica, disfunción endometrial, iatrógena, no clasificable).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Parámetros normales del ciclo menstrual.

REVERSO: Duración 3-8 días, volumen 5-80 ml por ciclo, intervalo entre sangrados 24-38 días y regularidad ± 2 días; fuera de estos rangos se habla de hemorragia uterina anormal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el método de imagen de primera elección en la HUA y cuándo se indica biopsia endometrial?

REVERSO: Ultrasonido (transvaginal). Biopsia endometrial si la línea endometrial es >12 mm en premenopáusicas o >5 mm en posmenopáusicas, sangrado persistente en ≥ 40 años o peso >90 kg.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el primer paso diagnóstico en toda mujer con vida sexual activa y sangrado uterino anormal?

REVERSO: Descartar embarazo (prueba de hCG) y verificar que el sangrado es de origen uterino con examen pélvico. Dato diferencial: los estudios de coagulación solo se obtienen si el sangrado es abundante desde la menarca o hay sospecha de coagulopatía (enfermedad de von Willebrand).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento inicial en adolescente sin vida sexual con HUA de origen no anatómico.

REVERSO: AINE (no requieren anticoncepción, no han iniciado vida sexual o cursan con dismenorrea); ante sangrado masivo: estrógenos conjugados 25 mg IV. Diferencial: el DIU con levonorgestrel se reserva para quienes desean anticoncepción.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Mujer de 30 años con HUA que desea anticoncepción. Tratamiento de elección.

REVERSO: Dispositivo intrauterino con levonorgestrel (cavidad uterina normal, sin infección genital ni neoplasia). Diferencial: el ácido tranexámico se usa cuando no se requiere anticoncepción y existen contraindicaciones para anticonceptivos orales.

Hiperplasia Endometrial

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se define la hiperplasia endometrial y en qué pacientes es más frecuente?

REVERSO: Crecimiento endometrial excesivo por estímulo estrogénico sostenido sin oposición de la progesterona; se ve en los extremos de la vida reproductiva (SOP, obesidad, tamoxifeno, posmenopausia, estrógenos sin progestinas).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué subtipo histológico tiene mayor potencial maligno y cuál es el riesgo?

REVERSO: Hiperplasia compleja atípica: 20-30% progresa a carcinoma endometrial sin tratamiento. Dato diferencial: la hiperplasia simple se maneja solo con vigilancia y progestinas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Punto de corte ultrasonográfico de la línea endometrial para tamizaje de hiperplasia endometrial.

REVERSO: Según la GPC: 25 mm en posmenopáusicas sintomáticas y >12 mm en posmenopáusicas asintomáticas y premenopáusicas; el diagnóstico definitivo se obtiene con biopsia endometrial.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de la hiperplasia endometrial simple.

REVERSO: Progestinas 10 días cada mes durante 3 meses, con repetición de la biopsia al término del ciclo terapéutico. Diferencial: ante atipias (descartado carcinoma) debe ofrecerse histerectomía como tratamiento definitivo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué opciones terapéuticas están contraindicadas en la hiperplasia endometrial?

REVERSO: La ablación endometrial (nunca recomendada) y el tratamiento médico en mujeres posmenopáusicas; si el reporte histológico es carcinoma, referencia a Oncología.

Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 24 años, 3 semanas después de una relación sexual de riesgo, con fiebre, adenopatías y rash máculopapular; ELISA negativo. ¿Qué prueba procede?

REVERSO: PCR de carga viral (detecta la infección aguda antes de la seroconversión). Dato diferencial: un ELISA negativo temprano no descarta VIH; la confirmación habitual es ELISA + Western blot.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el esquema TARV recomendado en el embarazo antes de las 8 semanas de gestación?

REVERSO: TDF/FTC + raltegravir (RAL); después de las 8 semanas: TDF/FTC o ABC/3TC + dolutegravir (DTG). Se inicia TARV en TODAS las embarazadas con VIH, independientemente de CD4 o carga viral.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la cesárea electiva en una gestante con VIH?

REVERSO: A la semana 38 si la carga viral es >1000 copias/mL o desconocida, si no recibió TARV o solo ZDV. Con carga viral <50 copias/mL puede considerarse parto vaginal. Para el ENARM, ante VIH materno la primera respuesta es cesárea.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Profilaxis intraparto en VIH con carga viral >50 copias/mL.

REVERSO: Zidovudina intravenosa iniciada 4 horas antes de la resolución: 2 mg/kg en la primera hora y después 1 mg/kg/h hasta el nacimiento. Dato diferencial: nevirapina NO está recomendada como profilaxis intraparto.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Profilaxis del recién nacido expuesto a VIH de bajo riesgo.

REVERSO: Zidovudina sola por 4 semanas, iniciada en las primeras 6-12 horas de vida. Dato diferencial: en riesgo alto se añade 3TC + NVP (o RAL), y la lactancia materna está contraindicada en toda madre con VIH.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cómo se diagnostica el VIH en un lactante menor de 18 meses hijo de madre seropositiva?

REVERSO: Prueba virológica (PCR de carga viral) a los 14-21 días, entre el 1º y 2º mes y entre los 4 y 6 meses; el ELISA no es útil por el paso transplacentario de anticuerpos maternos.

Infección por Virus del Papiloma Humano (VPH)

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué genotipos de VPH se consideran oncogénicos y a qué patología se asocian?

REVERSO: Los genotipos 16 y 18, asociados a cáncer cervicouterino y displasias cervicales; la vacuna nonavalente los cubre junto con 6, 11, 31, 33, 45, 52 y 58.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué genotipos causan los condilomas acuminados?

REVERSO: Genotipos 6 y 11 (bajo riesgo, no oncogénicos): verrugas genitales. Dato diferencial: el condiloma plano corresponde a sífilis secundaria (VDRL/FTA-ABS positivos), no a VPH.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cómo se diagnostica la infección por VPH?

REVERSO: Citología cervical (Papanicolaou) y prueba de detección de ADN viral (DNA-HPV) para genotipos de alto riesgo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Prevención primaria de la infección por VPH.

REVERSO: Vacunación tetravalente o nonavalente; es la base de la prevención del cáncer cervicouterino.

Infertilidad

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se define la infertilidad en función de la edad de la pareja?

REVERSO: Incapacidad de lograr embarazo con coitos sin anticoncepción: 1 año si la mujer es menor de 35 años y 6 meses si es mayor o igual a 35. La edad materna es la variable con mayor impacto en el pronóstico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el primer estudio del factor masculino y cómo se prepara?

REVERSO: Análisis seminal tras 2-3 días de abstinencia eyaculatoria; las anormalidades seminales causan 30-40% de los casos. Dato diferencial: teratozoospermia = más del 50% de formas anormales.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cómo se documenta la ovulación y la permeabilidad tubárica?

REVERSO: Ovulación: progesterona sérica en fase lútea y curva de temperatura basal (el ultrasonido pélvico es el mejor método para documentarla); tubas: histerosalpingograma, en la semana siguiente a la menstruación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Pareja con infertilidad por anovulación. Fármaco de primera línea.

REVERSO: Citrato de clomifeno (tratamiento inicial estándar según la GPC); en SOP sin respuesta se usa FSH recombinante; hiperprolactinemia: agonistas dopaminérgicos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer tratada con gonadotropinas posmenopáusicas presenta distensión abdominal, ascitis, hemoconcentración e hipercoagulabilidad. ¿Diagnóstico y mediador?

REVERSO: Síndrome de hiperestimulación ovárica (0.5% de las tratadas): leve con ovario >6 cm, moderado >10 cm con ascitis, náusea y vómito, y severo con hemoconcentración y oliguria; implicado el VEGF.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué causa de infertilidad tiene el mejor pronóstico y cuál el peor?

REVERSO: Mejor pronóstico: anovulación (mayor tasa de éxito con el tratamiento); peor: enfermedad tubárica, junto con edad mayor de 35 años y espermatozoides anormales.

Isoinmunización al Factor Rh

Tarjeta 1 -- FRENTE: Gestante Rh-negativa no sensibilizada, ¿cuándo debe recibir inmunoglobulina anti-D?

REVERSO: Rutinaria a las 28 semanas y en las 72 horas siguientes al parto de un producto Rh-positivo; también ante aborto, embarazo ectópico, hemorragia anteparto, amniocentesis o trauma abdominal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿En qué situaciones NO está indicada la profilaxis con inmunoglobulina anti-D?

REVERSO: Cuando el neonato es Rh-negativo o presenta Coombs directo positivo (por ejemplo, 40 horas posparto con Coombs positivo): ya existe hemólisis o no hay que prevenir sensibilización.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Dosis de inmunoglobulina anti-D según edad gestacional.

REVERSO: 300 µg IM si es mayor de 13 semanas; 50-150 µg IM si es menor de 13 semanas; posparto con Rosette negativa: 300 µg dentro de las primeras 72 horas.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es la herramienta más valiosa para detectar anemia fetal por isoinmunización?

REVERSO: Ultrasonido Doppler de la velocidad máxima en la arteria cerebral media fetal; tiene falsos positivos después de la semana 35, por lo que puede recurrirse a la espectrofotometría del líquido amniótico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgos ultrasonográficos de la hidropesía fetal.

REVERSO: Ascitis, derrame pleural o pericárdico, edema cutáneo (halo cefálico doble), hepatoesplenomegalia, polihidramnios y placentomegalia; su presencia indica intervención terapéutica sin

amniocentesis diagnóstica.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Manejo de la enfermedad hemolítica fetal establecida.

REVERSO: Transfusiones intrauterinas de paquetes globulares Rh-negativos cada 1-3 semanas (última típicamente entre las 32-34 semanas); supervivencia global de 85% tras transfusión intrauterina.

Liquen Plano Vulvar

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 55 años con lesiones vulvares erosivas, brillantes, con estrías blanquecinas serpenteantes, dolor y ardor. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Liquen plano vulvar en su forma erosiva (la más frecuente). Dato característico: estrías de Wickham en labios menores y vestíbulo, rodeadas de tejido aparentemente normal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué estudio se solicita en el liquen plano vulvar y con qué objetivo?

REVERSO: Biopsia en sacabocado de 4 mm que incluya tejido aparentemente normal, para descartar carcinoma vulvar, en especial en la forma hipertrófica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea del liquen plano vulvar.

REVERSO: Corticoides superpotentes tópicos (clobetasol) o cursos cortos sistémicos; segunda línea: tacrolimus tópico; la cirugía se reserva para liberar sinequias vaginales graves.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué hallazgo acompaña al 70% de las formas erosivas del liquen plano vulvar?

REVERSO: Involucramiento vaginal (friabilidad del epitelio, denudación y exudado seropurulento; adhesiones y sinequias en formas graves). Dato diferencial: en el liquen escleroso la afectación vaginal es rara.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Forma habitual de presentación del liquen plano vulvar.

REVERSO: Dolor, ardor, prurito, dispareunia y descarga vaginal irritante que no responde al tratamiento estándar de las vaginitis; puede coexistir con lesiones orales y alopecia fibrosante frontal.

Malformaciones Müllerianas Uterinas

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es la malformación mülleriana uterina más frecuente?

REVERSO: Útero septado (35%), seguido del útero bicorne (25%) y del arcuato (20%); en mujeres con aborto recurrente la prevalencia de malformaciones sube a 16.7%.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de malformaciones müllerianas?

REVERSO: Resonancia magnética; es la técnica de elección cuando ecografía e histerosalpingografía no son concluyentes y antes de la laparoscopia en didelfo, bicorne y septado. La ecografía 3D es la técnica no invasiva que diferencia septado de bicorne.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Por qué la histerosalpingografía no puede diferenciar útero septado de bicorne?

REVERSO: Porque solo evalúa el interior de la cavidad uterina y no el contorno externo (fondo); se requiere ecografía 3D o resonancia magnética.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Clasificación AFS de las malformaciones müllerianas uterinas.

REVERSO: Clase I agenesia/hipoplasia, II unicorne, III didelfo, IV bicorne, V septado, VI arcuato y VII relacionada con dietilestilbestrol (DES).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué estudio complementario es obligado ante una malformación mülleriana y por qué?

REVERSO: Ultrasonido renal (y en algunos casos pielografía intravenosa), porque estas malformaciones se asocian en un porcentaje alto a anomalías de la vía urinaria.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Forma habitual de presentación de las malformaciones müllerianas.

REVERSO: Mayoría asintomáticas; se diagnostican por dismenorrea, masa pélvica, alteraciones menstruales, infertilidad o pérdida gestacional recurrente; las aplasias vaginales (tipo I) se detectan con la inspección de genitales externos.

Menopausia

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se diagnostica la menopausia?

REVERSO: Clínicamente: 12 meses consecutivos de amenorrea sin causa patológica (diagnóstico retrospectivo); edad media en México de 49 años (rango 47-49). En mayores de 45 años no se diagnostica por laboratorio.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuándo se solicita FSH y qué valores se esperan?

REVERSO: Solo ante duda diagnóstica o menopausia precoz (<40 años): FSH >30-40 mUI/mL con estradiol <20 pg/mL; FSH >25 UI/L es compatible con la transición menopáusica; TSH normal para descartar tiroidopatía.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de elección de los síntomas vasomotores de la menopausia.

REVERSO: Terapia hormonal en menores de 60 años o con menos de 10 años desde la menopausia: estrógeno más progestágeno si el útero está intacto y solo estrógeno si está histerectomizada. No está indicada para prevención cardiovascular.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Esquema hormonal en perimenopáusica con útero que desea ciclos frente a posmenopáusica con útero.

REVERSO: Perimenopáusica: terapia cíclica continua (secuencial): estrógeno diario más progesterona 10-14 días al mes; posmenopáusica con útero: continua combinada con dosis fijas diarias de ambas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué vía de administración se elige en la mujer climatérica hipertensa o con riesgo trombótico, y qué vía se reserva para la atrofia genitourinaria?

REVERSO: Vía transdérmica (hipertensión, hipertrigliceridemia, hepatopatía crónica, riesgo de trombosis venosa); la vía tópica vaginal solo para atrofia genitourinaria (no requiere progestágeno asociado).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Diagnóstico y tratamiento de primera línea de la osteoporosis posmenopáusica.

REVERSO: DEXA (estándar de oro): osteoporosis con T-score <-2.5; primera línea farmacológica: bifosfonatos (alendronato), con calcio 1500 mg/día y vitamina D en posmenopáusicas.

Miomatosis Uterina

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 40 años con hipermenorrea y útero agrandado e irregular, indoloro. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Miomatosis uterina (leiomiomas): tumor benigno de músculo liso con pico de 35-45 años y malignización <1%. El síntoma más frecuente es la hipermenorrea (21.4%), con anemia secundaria.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el comportamiento de los miomas según el estado hormonal?

REVERSO: Dependientes de estrógenos: crecen durante el embarazo y regresan en la posmenopausia. En el embarazo puede presentarse la degeneración roja (infarto agudo) o la carnososa dolorosa (5-10%), por hemorragia intratumoral.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de imagen de elección para miomas uterinos.

REVERSO: Ultrasonido abdominal o transvaginal (sensibilidad hasta 85% en miomas >3 cm); histeroscopia si no es concluyente; resonancia magnética solo ante dificultad diagnóstica.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Mujer con miomatosis y deseo de fertilidad. Tratamiento.

REVERSO: Miomectomía (vía según tamaño y localización); goserelina por menos de 6 meses prequirúrgica reduce el tamaño del mioma hasta en 60%.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento definitivo de la miomatosis sintomática con paridad satisfecha.

REVERSO: Histerectomía. Alternativas: embolización de la arteria uterina y DIU con levonorgestrel para control de la hemorragia; los miomas pequeños asintomáticos solo requieren vigilancia con ultrasonido cada 6-12 meses.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué mioma causa dolor agudo y qué complicaciones puede generar la miomatosis?

REVERSO: El mioma pediculado por torsión o el submucoso por prolapso. Complicaciones: hemorragia uterina anormal con anemia, compresión abdominal, hidronefrosis e infertilidad.

Muerte Fetal

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo define la OMS la muerte fetal?

REVERSO: Muerte del feto antes de su expulsión o extracción completa, sin respiración, latido cardíaco, pulso del cordón ni movimientos; se establece desde las 22 semanas de gestación o peso mayor de 500 g.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tres datos clínicos que obligan a descartar muerte fetal.

REVERSO: Ausencia de movimientos fetales, ausencia de crecimiento uterino y ausencia de frecuencia cardíaca fetal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de elección para confirmar la muerte fetal.

REVERSO: Ultrasonido en tiempo real; en su ausencia, radiografía de abdomen: el signo del halo (Damel) es el primer signo radiográfico, dentro de las 48 horas post mortem.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Signo radiográfico de Spalding.

REVERSO: Superposición de las suturas craneales por licuefacción encefálica, entre el 1º y el 14º día tras la muerte fetal. Dato diferencial: signo de Robert = gas en vasos y vísceras (del día 10 a la 2ª semana).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Conducta ante una muerte fetal diagnosticada.

REVERSO: Manejo expectante o intervencionista; en este último se prefiere la inducción para parto vaginal, con cesárea solo si hay contraindicación materna (hemorragia, preeclampsia, cirugía uterina previa) o fetal (situación transversa) o inducción fallida. Estudiar la causa con autopsia, cariotipo y examen de placenta.

Neoplasias Ováricas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 62 años con distensión abdominal, saciedad precoz, ascitis y tumor pélvico fijo con nodulaciones en fondo de saco. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Cáncer de ovario epitelial: cursa asintomático hasta la invasión del abdomen superior; 70% se diagnostica en estadio III-IV. Datos asociados: ganglio de la hermana Mary Joseph y derrame pleural.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Subtipo histológico epitelial más frecuente y hallazgo patognomónico.

REVERSO: Adenocarcinoma seroso papilar (55%); los cuerpos de psammoma son patognomónicos y ~30% son bilaterales. Dato diferencial: el cistadenocarcinoma mucinoso (20%) puede medir 20 cm.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el papel del CA-125 en el cáncer de ovario?

REVERSO: Se eleva en 80% de los tumores serosos, pero carece de valor diagnóstico: solo se cuantifica para vigilancia postratamiento; el tamizaje con CA-125 y ultrasonido no se recomienda (valor predictivo positivo

<10%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el método de elección para confirmar el diagnóstico de cáncer de ovario?

REVERSO: Laparotomía exploradora con estadiaje quirúrgico (histerectomía total, salpingooforectomía bilateral, omentectomía y linfadenectomía); es la única modalidad con potencial curativo. Quimioterapia adyuvante: paclitaxel con platino.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Mujer joven con tumor ovárico productor de α FP con cuerpos de Schiller-Duval. ¿Diagnóstico y tratamiento?

REVERSO: Tumor del seno endodérmico (saco vitelino): resección y quimioterapia con bleomicina, etopósido y cisplatino. Diferenciales: disgerminoma produce DHL y coriocarcinoma produce hCG.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Tumor estromal con cuerpos de Call-Exner y otro que produce síndrome de Meigs.

REVERSO: Tumor de células de la granulosa (secreta estrógenos; cuerpos de Call-Exner, pseudo-precocidad) y tecoma (síndrome de Meigs: tumor con ascitis e hidrotórax derecho). El Sertoli-Leydig causa virilización; el tumor de Krukenberg es metástasis gástrica con células en anillo de sello.

Parto Pretérmino

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de trabajo de parto pretérmino.

REVERSO: Entre las 22-36.6 semanas: contracciones uterinas (2 en 10 min, 4 en 20 min u 8 en 60 min) más cambios cervicales (borramiento >80% o dilatación ≥ 3 cm). Dato diferencial: los cambios cervicales, no las contracciones, son los buenos predictores.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el marcador más sensible para parto pretérmino?

REVERSO: Longitud cervical por ecografía (evaluada a las 20-34 semanas); la fibronectina fetal se prueba a las 24-34 semanas. Ambas tienen alto valor predictivo negativo; con longitud <15 mm o fibronectina positiva se repite la prueba en 14 días.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tocolítico de primera línea y limitación de la segunda línea.

REVERSO: Nifedipino oral (primera línea); indometacina es segunda línea y solo hasta las 32 semanas por el riesgo de cierre del conducto arterioso. Los antibióticos no prolongan la gestación.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Esquema de maduración pulmonar fetal en parto pretérmino.

REVERSO: Entre las 24-36.6 semanas: betametasona 12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis, o dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por 4 dosis.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Neuroprotección fetal en parto pretérmino inminente.

REVERSO: Sulfato de magnesio entre las 24-31 semanas (puede considerarse hasta las 33.6); reduce la morbilidad neurológica neonatal.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Contraindicaciones de la tocólisis.

REVERSO: Preeclampsia severa, sangrado placentario, desprendimiento placentario, corioamnionitis, restricción del crecimiento fetal, anomalías letales y muerte fetal; si el parto es inminente y hay estreptococo del grupo B: penicilina o ampicilina.

Poliposis Endometrial

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer posmenopáusica con sangrado y engrosamiento focal de la línea endometrial en ultrasonido. ¿Diagnóstico más probable?

REVERSO: Pólipo endometrial (causa menorragia y sangrado posmenopáusico); se reconoce mejor con ultrasonido con infusión salina (histerosonograma) o histeroscopia.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Por qué los pólipos endometriales pueden evadir el aspirado endometrial o el legrado?

REVERSO: Porque son demasiado grandes para aspirarse y suficientemente flexibles para evadir el filo de la legra; por ello la evaluación histológica del pólipo resecado es imperativa.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Indicaciones de polipectomía histeroscópica.

REVERSO: Pólipo mayor de 1.5 cm (riesgo incrementado de hiperplasia o malignidad), múltiples pólipos, recurrencia, sangrado uterino anormal, infertilidad, pólipo prolapsado o factores de riesgo de cáncer endometrial.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Complicación principal del pólipo endometrial.

REVERSO: Coexistencia u ocultamiento de hiperplasia, carcinoma o carcinosarcoma endometriales dentro del pólipo, lo que obliga al estudio histopatológico sistemático.

Puerperio

Tarjeta 1 -- FRENTE: Clasificación temporal del puerperio.

REVERSO: Temprano (precoz): primeras 24 horas, con riesgo de complicaciones agudas como la hemorragia; mediato: del 2º al 7º día; tardío: del 8º día hasta las 6 semanas (42 días).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Evolución normal de los loquios.

REVERSO: Rojos los primeros días, serosos a los 3-4 días y alba hacia el día 10; duración promedio de 24-36 días. Dato diferencial: loquios malolientes sugieren endometritis.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Involución uterina en el puerperio.

REVERSO: Útero de ~500 g a la semana 1, ~300 g a las 2 semanas y ~100 g a las 4 semanas (involución completa); la lactancia la favorece por liberación de oxitocina.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Escala de tamizaje de sepsis materna y conducta.

REVERSO: omqSOFA: dos o más de presión sistólica <90 mmHg, frecuencia respiratoria ≥25 rpm o alteración del estado de conciencia; confirmar disfunción orgánica con omSOFA >2. Antibiótico IV empírico en la primera hora; en choque séptico, norepinefrina.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Endometritis puerperal: datos y tratamiento antibiótico empírico.

REVERSO: Fiebre >38 °C, dolor, loquios fétidos e involución retardada; etiología polimicrobiana (E. coli es el aerobio más común, más anaerobios). Esquema: gentamicina + cefotaxima + metronidazol (o ampicilina + gentamicina si <37 semanas).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Puérpera con fiebre persistente en espigas pese a antibióticos.

REVERSO: Tromboflebitis de venas pélvicas (usualmente del lado derecho) por estasis venosa; responde a heparina no fraccionada. Diferencial: absceso pélvico requiere drenaje quirúrgico.

Restricción del Crecimiento Intrauterino

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se distingue un feto pequeño para la edad gestacional (PEG) de uno con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)?

REVERSO: PEG: peso fetal estimado en percentil <10 pero >3 con flujometría Doppler normal; RCIU: percentil <3, o entre >3 y <10 con Doppler multivasos alterado (incapacidad de alcanzar el potencial genético).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Parámetros evaluados en la flujometría Doppler multivasos.

REVERSO: Arteria cerebral media, arteria umbilical, índice cerebro-placentario y ductus venoso; es el estudio que define RCIU cuando el percentil se encuentra entre >3 y <10.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Feto con peso estimado <p10 y flujo diastólico ausente en arteria umbilical. ¿Tipo, vigilancia y edad de finalización?

REVERSO: RCIU tipo II: revalorar Doppler cada 24-48 horas y finalizar a partir de las 34 semanas, preferentemente por cesárea.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Flujo diastólico reverso en arteria umbilical o ductus venoso >p95. ¿Tipo y finalización?

REVERSO: Tipo III: finalizar a partir de las 30 semanas; si hay flujo reverso en ductus venoso, variabilidad <5 lpm o ≥2 desaceleraciones en 10 minutos (tipo IV), desde las 26 semanas, por cesárea.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Vía de nacimiento según el tipo de restricción del crecimiento.

REVERSO: PEG sin restricción o tipo I: parto vaginal con cardiotocografía continua; tipos II, III y IV: cesárea electiva.

Ruptura Prematura de Membranas

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se define la ruptura prematura de membranas (RPM)?

REVERSO: Amniorrexis antes del inicio del trabajo de parto, a cualquier edad gestacional; es pretérmino (RPPM) si ocurre antes de las 37 semanas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Confirmación diagnóstica de la RPM ante duda.

REVERSO: Espéculo vaginal estéril con visualización directa del líquido; complementarias: nitrazina (sensibilidad 93%) y cristalografía (88%). El tacto vaginal está prohibido sin trabajo de parto.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Datos clínicos de corioamnionitis en RPM.

REVERSO: Temperatura >37.8 °C, secreción vaginal fétida y frecuencia cardíaca fetal >160 lpm; ante infección establecida: antibióticos e interrupción del embarazo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo de la RPPM entre las 24-34 semanas sin corioamnionitis.

REVERSO: Expectante: corticoides (24-34 semanas), antibióticos ampicilina + eritromicina IV por 48 horas seguidos de amoxicilina + eritromicina orales por 5 días, y vigilancia materno-fetal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Manejo de la RPM después de las 34 semanas.

REVERSO: Interrupción del embarazo: no existe beneficio en prolongarlo. Diferencial: la amoxicilina/ácido clavulánico está contraindicada por riesgo de enterocolitis necrotizante.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Está indicada la tocólisis en la RPM?

REVERSO: No (dato recurrente en el ENARM); tampoco se prolonga la gestación después de las 34 semanas. Con RPM y cerclaje, el cerclaje debe retirarse; la paciente se hospitaliza.

Sífilis (*Treponema pallidum*)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Úlcera genital única, indolora e indurada, de 3 semanas de evolución. ¿Diagnóstico y fase?

REVERSO: Chancro sífilítico, sífilis primaria. Dato diferencial: las úlceras del herpes o del chancroide son dolorosas; el chancro sífilítico es indoloro.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Exantema máculopapular palmoplantar con condilomas planos. ¿Fase?

REVERSO: Sífilis secundaria. Dato diferencial: el condiloma plano es sifilítico; el condiloma acuminado (verrugas) es por VPH (genotipos 6 y 11).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Pruebas diagnósticas de la sífilis.

REVERSO: VDRL (prueba no treponémica de tamizaje) confirmada con FTA-ABS (prueba treponémica).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de la sífilis.

REVERSO: Penicilina G benzatínica intramuscular, tratamiento de elección en todas las fases y el estándar en el embarazo.

Síndrome de Ovarios Poliquísticos

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de Rotterdam para el síndrome de ovarios poliquísticos.

REVERSO: Cumplir al menos 2 de 3: hiperandrogenismo clínico o bioquímico, oligoovulación o anovulación, y ovarios poliquísticos ('collar de perlas' en ecografía); es un diagnóstico de exclusión.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Perfil hormonal característico del SOP.

REVERSO: Índice LH/FSH >2, hiperandrogenismo con SHBG disminuida (testosterona libre elevada) e hiperinsulinemia por resistencia a la insulina.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Manifestaciones clínicas más frecuentes del SOP.

REVERSO: Hirsutismo (90%), irregularidad menstrual (90%) e infertilidad (75%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Mujer con SOP e infertilidad por anovulación. Tratamiento de primera línea.

REVERSO: Clomifeno o tamoxifeno (GPC); en ausencia de respuesta, FSH recombinante; metformina como parte del manejo metabólico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Manejo integral del SOP.

REVERSO: Control ponderal con metformina para la hiperinsulinemia, anticonceptivos combinados para supresión ovárica, bloqueo androgénico con espironolactona y progestágenos si hay oligomenorrea o amenorrea.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Por qué se administran progestágenos cíclicos en el SOP?

REVERSO: Para inducir hemorragia por privación al menos cada 3-4 meses y prevenir la hiperplasia endometrial (y su progresión a cáncer endometrial) por el estímulo estrogénico sin oposición.

Trastornos Hipertensivos del Embarazo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de preeclampsia.

REVERSO: Hipertensión >140/90 mmHg (2 tomas con al menos 4 horas de margen) después de la semana 20, más proteinuria ≥ 300 mg en 24 horas (o 1+ en tira, o relación proteína/creatinina >0.30); también se diagnostica con hipertensión más un dato de severidad aun sin proteinuria.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tres componentes del síndrome HELLP.

REVERSO: Hemólisis (esquistocitos en frotis, bilirrubina >1.2 mg/dl), elevación de enzimas hepáticas (AST >70 U/L, DHL >600 U/L) y plaquetas <100,000/ μ l; es una variante de preeclampsia severa.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Gestante de 26 semanas con Hb 8 g/dl, LDH 670, AST 182 y plaquetas 80,000. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Preeclampsia severa con síndrome HELLP (cumple hemólisis, DHL >600, AST >70 y plaquetas <100,000); la resolución del embarazo es la única cura.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo de la crisis ecláptica.

REVERSO: Sulfato de magnesio IV: bolo de 4-6 g seguido de 1-2 g/hora hasta 24 horas posparto o tras la última convulsión; ante recurrencia, 2-4 g IV en 5 minutos. Alternativa: fenitoína. Estabilizar a la madre antes de resolver el embarazo.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Crisis hipertensiva en preeclampsia ($TAS \geq 160$ o $TAD \geq 110$). Fármaco de primera línea y dosis.

REVERSO: Nifedipino 10 mg VO cada 10-15 minutos (máximo 50 mg); segunda línea hidralazina IV 5-10 mg y tercera labetalol IV. Los IECA y ARA-II están contraindicados en el embarazo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Prevención de la preeclampsia en gestantes de alto riesgo.

REVERSO: Ácido acetilsalicílico 100-150 mg/día iniciado antes de la semana 16, más calcio elemental 1.5-2 g/día si la ingesta dietética es baja (<600 mg/día); no están indicados el reposo ni la restricción de sodio.

Trastornos de las Glándulas Vestibulares Mayores (Bartolinitis)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Tumoración vulvar dolorosa en el radio de las 4 u 8 horarias, con hipertermia local y dispareunia. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Absceso de la glándula de Bartholin (bartolinitis). Dato diferencial: el quiste de retención glandular es asintomático; fuera de la localización glandular debe pensarse en otras tumoraciones vulvares.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tratamiento del absceso de Bartholin.

REVERSO: Drenaje por incisión o marsupialización quirúrgica, con antibióticos de espectro amplio, antiinflamatorios y analgésicos; el quiste asintomático no requiere tratamiento.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cómo se diagnostica la bartolinitis?

REVERSO: Eminentemente clínico; biopsia y cultivo solo para identificar el agente etiológico si la presentación es atípica. Su diagnóstico es por sí mismo indicación de referencia al segundo nivel de atención.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Complicación potencial de la bartolinitis sin tratamiento oportuno.

REVERSO: Fascitis necrosante. Agentes habituales: estafilococos, estreptococos, E. coli y bacterias perineales o de transmisión sexual.

Tricomoniasis (Trichomonas vaginalis)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer con leucorrea profusa, maloliente, amarillo-verdosa y espumosa, pH >4.5 , y cerviz con petequias ('colpitis en fresa'). ¿Diagnóstico?

REVERSO: Tricomoniasis por Trichomonas vaginalis. Diferenciales: vaginosis bacteriana (flujo gris con olor a pescado, sin colpitis en fresa) y candidiasis (flujo blanquecino grumoso con pH normal).

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cómo se confirma el diagnóstico de tricomoniasis?

REVERSO: Microscopía en fresco (sensibilidad 70% en mujeres y solo 30% en varones), KOH al 10%, NAAT y cultivo; si la citología reporta T. vaginalis debe confirmarse con cultivo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la tricomoniasis.

REVERSO: Metronidazol 500 mg VO cada 12 horas por 7 días o 2 g VO en dosis única (ambos según la GPC), tratando siempre a la pareja sexual; tinidazol 2 g en dosis única para casos resistentes.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué proporción de las pacientes cursa asintomática?

REVERSO: Alrededor del 50% de las mujeres; los varones suelen ser asintomáticos y actúan como fuente de reinfección, por lo que el tratamiento incluye a la pareja.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué genotipos de VPH son oncogénicos?

REVERSO: Los genotipos 16 y 18 (riesgo de cáncer cervicouterino); los de bajo riesgo 6 y 11 causan condilomas acuminados.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Genotipos cubiertos por la vacuna nonavalente.

REVERSO: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué lesiones genitales se asocian a los genotipos 6 y 11?

REVERSO: Condilomas acuminados (verrugas genitales), lesiones de bajo riesgo no oncogénicas; las displasias cervicales se asocian a genotipos de alto riesgo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Herramientas de tamizaje y diagnóstico del VPH.

REVERSO: Citología cervical (Papanicolaou) para tamizaje y prueba de DNA-HPV para detección de genotipos de alto riesgo; la prevención es la vacunación tetravalente o nonavalente.

Vulvodinia

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer de 35 años con ardor, picazón e irritación vulvar de más de 3 meses, sin lesiones visibles ni alteraciones neurológicas. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Vulvodinia (dolor vulvar >3 meses, generalizada o localizada); síndrome doloroso complejo regional, comparable a la cistitis intersticial y la fibromialgia.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la prueba diagnóstica característica de la vulvodinia?

REVERSO: Prueba de presión con hisopo en los puntos cardinales del vestíbulo y la piel circundante, que delimita la topografía del dolor; el diagnóstico es por exclusión de otras entidades.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de segundo nivel de la vulvodinia.

REVERSO: Tópico: gel de lidocaína (especialmente antes del coito); sistémico: amitriptilina, gabapentina, carbamazepina o venlafaxina.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Manejo de la vulvodinia refractaria (tercer nivel).

REVERSO: Infiltración local con lidocaína y metilprednisolona, o medidas quirúrgicas (vestibuloplastia o vestibulectomía parcial).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Diagnóstico diferencial de la vulvodinia con el liquen escleroso.

REVERSO: El liquen escleroso presenta lesiones blancas con piel adelgazada y arrugada y prurito potencialmente severo; la vulvodinia cursa sin lesiones evidentes. El herpes vulvar cursa con vesículas dolorosas.